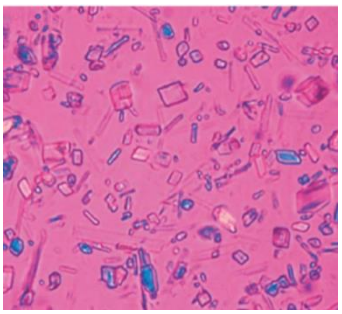
<2021 본 3 학년말고사- 정형외과>

총 **25 문제** 중 **25 문제** 복원

경향 : 20 야마를 베이스로 변형이 많이 되었습니다.

1. 83 세 남성 무릎 통증 및 열감으로 내원, V/S stable 하였으며 신체검사상 삼출, 홍반 부종 관찰. 무릎 X-ray 와 관절천자 후 편광현미경 검사 결과이다. 진단은?

- OA
- RA
- 통풍
- <u>가성통풍</u>
- AVN

2. 31 세 여성 교통사고 후 서혜부 통증으로 내원 함. 다리를 움직일 수 없었음. 적절한 치료?



- <u>금속내고정술</u>
- 부목
- 피부견인
- 대퇴골견인
- 외고정

3. 침대에 누운자세(Supine position)에서는 고관절의 외전운동 능동적으로 가능. 옆으로 누워서는 아무런 움직임 제한 없이도 움직일 수 없었음. 이때, 근력 평가를 한다면?

- 5 - Normal
- 4 - Good
- 3- Fair
- <u>2- Poor</u>
- 1- Trace

4. 60 대 여성 6 개월 전부터 무릎 통증이 있었다. 걸으면 악화되고 쉬면 나아지는 양상이었다. 엑스레이 소견은 다음과 같았다. 적절한 예방 방법은?




- 금연
- 금주
- <u>체중감량</u>
- 저퓨린식단
- 저칼륨식단

5. 50 대 여성, 손목이 찌릿찌릿 설거지할때 악화된다. 밤에 아파서 깰 때도 있다. 아침에 뻐근해서 손을 털어야 한다. 다음 중 이 환자가 가장 양성을 나타낼 것 같은 시험은?

- <u>Phalen test</u>
- Finkelstein test
- Allen test
- Spurling test

6. 좌측 상지에 뻗치는 통증으로 내원하였다. 세번째 손가락에 감각이 없었다. 이학적 검사에서 주관절 신전이 안되고, 삼두근 반사가 저하되었다. 문제가 생긴 위치?
   - 경추 3-4 사이
   - 경추 4-5 사이
   - 경추 5-6 사이
   - 경추 6-7 사이
   - 경추 7 흉추 1 사이

7. 35 세 남성, 우측 하지 방사통으로 내원하였다. SLRT (+), 방사통 유발되었고, 무릎을 구부려서 통증을 완화시킨 후, 그 상태에서 좌골 신경 부위를 눌렀더니 통증이 생겼다. 이 검사방법은?
   - SLRT
   - Bowstring
   - Bragard
   - Lasegue test
   - Gaenslen test

8. 요통을 주소로 내원한 환자. 무지 굴곡이 안되고, 아킬레스건 반사가 감소하였다. MRI 상에서 중심 추간판 탈출증이 보였다. 문제가 생긴 위치?
   - 요추 1-2 사이
   - 요추 2-3 사이
   - 요추 3-4 사이
   - 요추 4-5 사이
   - 요추 5-천추 1 사이

9. 척추관 협착증의 증상으로 '주로 양측하지의 통증, 저린감, 근력약화가 나타나고 통증은 요배부, 둔부에서 시작하여 무릎쪽으로 퍼지는 양상임. 통증이 걷는 중에 발생하여 앉거나 쉬면 나아지는 것'을 이르는 말은?
   - 배뇨장애
   - 보행장애
   - 신경성 간헐적 파행
   - SLRT
   - 혈관성 파행

10. 다발성 외상 환자에서 적절한 수술 시기 결정하는데 가장 중요한 지표는?
   - Lactate
   - PaO2
   - PCO2
   - PLT count
   - Hb

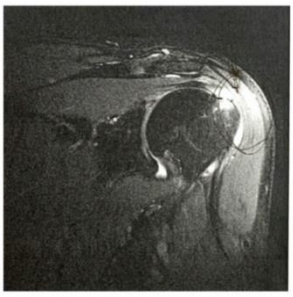
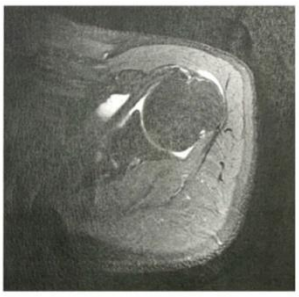
11. 우측 중지의 통증을 주소로 내원하였다. 우측 엄지에 통증이 있었고, 구부리려고 하면 잘 안됐으며 한 번 구부러지면 다시 펴기 힘들었다. 증상은 아침에 더 심했고, 운동을 하다보면 호전되었다. 움직이려고 할 때 걸리는 느낌이 있다가 펴지는 양상이라고 하였다. 원인이 되는 해부학적 구조는? (중지-엄지 오타 아님)
   - Collateral ligament
   - A1 pulley
   - Volar plate
   - Extensor pollicis brevis
   - Abductor pollicis brevis

12. 다음 사진과 같이 골절의 불유합이 일어나는 가장 흔한 이유는 ?



   - Inadequate fracture stability
   - Impaired vascularity at fracture site
   - Comorbid medical condition

13. 60 대, 견관절 전방 탈구 되었던 환자가 견관절 외측 감각은 정상적으로 1 달이 지나도 팔이 능동으로 올라가지 않고, 수동으로 들어올리면 올라갔다. Deltoid 근력은 정상되었다. 손상된 구조물은 ? (MRI Coronal, Axial 사진 보여줬고, 딱 봐도 rotator cuff tear 의심할 수 있는 사진이었습니다.)

- 회전근개 파열
- 재발성 견갑탈골
- 액와신경손상
- 외상성 탈골

14. Tibia fracture 후 통증으로 내원, 부종, 수포, 주관절 수동 신전시 통증, 이상감각 없고, 맥박은 있었다. 적절한 처치는?

- 근막절개술 및 외고정술
- 구획압측정
- 거상 및 얼음찜질
- IM nailing

15. Tibia 골절 후 심각한 통증으로 내원. 부종, 수포, 이상감각 호소. 진단은?



- 구획증후군
- 지방색전증
- 압궤증후군
- 석고증후군
- 외상성 반사성 교감신경 이영양증

16. A-B-C 순서대로 (distal femur 분쇄골절, Open wound, Hip dislocation) 혈압 100/70 HR 90 가장 먼저 해야 할 치료는?






- 창상 세척 및 변연절제술
- Hip 도수정복
- 대퇴골 외고정
- 대퇴골두 IM nailing
- 부목고정

17. 60 세 여, 스테로이드 투여 6 개월 후 정형외과 내원. 보행시 심한 왼쪽 고관절 통증을 호소하였다. 약물치료 후 반응이 없었다. 고관절 MRI 결과이다. 치료는?



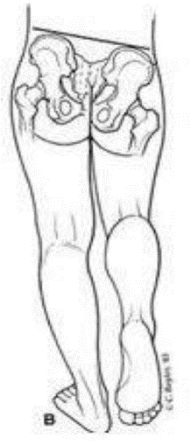
- 인공관절치환술
- 경과관찰
- 다발성 천공술
- 회전성 절골술
- 중심감압술

18. 24 세 남, 교통사고 발생한 우측 상완의 나선형 원위 간부 골절로 내원하였다. 도수정복술 및 우측 손목의 신전, 무지 신전이 안되었다. 손상된 신경은?



- 척골신경
- 요골신경
- 정중신경
- 근피신경
- 액와신경

19. 다음 이학적 검사에서 손상 받은 근육은 ?



- 우측 중둔근
- 우측 장요근
- 좌측 중둔근
- 좌측 장요근

20. (Y)80 세 여성이 빙판길에서 미끄러져 발생한 손목 통증을 내원하였다. 손가락을 움직이는 데에는 문제가 없었으나 움직일 때 손목에 통증이 발생하였다. 올바른 처치는?



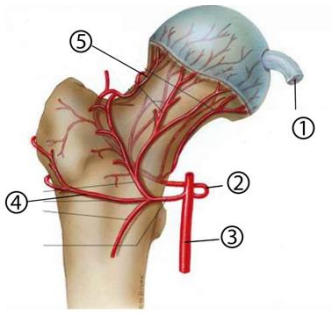
- 설탕집게 부목
- 단상지 부목
- 장상지 부목
- 무지상 석고 부목
- Ulnar gutter splint

21. 환자가 키우던 개에 물려 응급실에 내원하였다. 손 dorsum 부위에 2x2 의 피부 결손이 있고, 일부 연부조직 손상이 있었고 종창 열감 통증이 있었다. 처치는?

- 전층 피부 이식 (Full thickness skin graft)
- 부분층 피부 이식 (Split skin graft)
- 피판이식 (Flap)
- 창상 부위 세척 후 일차 봉합술(Primary wound closure)
- 창상 부위 세척 후 이차 봉합술(Delayed wound closure)

22. 고관절 Femur head 수술 받은 사람, 통증을 호소하여 내원하였음. 다음중 가장 문제 있는 혈관은?





- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

23. 다음과 같은 검사를 시행 했을 때, 양성 (no end point , mushroom)을 보였다. 원인이 되는 구조물은?



- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Medial collateral ligament
- Lateral collateral ligament
- Anterolateral ligament

24. 남자가 경골이 후방전위되었다. 가장 손상받았을 확률이 높은 구조는?



- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Medial collateral ligament
- Lateral collateral ligament
- Meniscus

25. 수년 전부터 어깨 통증 호소, MRI 상에서 광범위한 회전근개 파열이 있었음. 위쪽 관절 사이가 6mm 로 좁아져있었다. 적절한 치료 방법은?



- 회전근개 봉합술
- 인공관절 치환술
- 견봉성형술 및 변연절제술

* 조영훈 교수님 피셜,, 봉합하기 힘들정도로 상태가 안좋은 회전근개 파열은 인공관절치환술해야 한다. (정확히는 Reverse shoulder arthroplasty 가 맞다고 하심.)